

Anesthésie et cardiopathie congénitale de l'adulte

Risque préopératoire, stratégie anesthésique, postopératoire, obstétrique, annexes & sources



Résumé : la mortalité périopératoire en chirurgie non cardiaque est 2 à 7 % chez l'adulte porteur de cardiopathie congénitale (CC), contre une population témoin bien plus faible — la CC est un facteur de risque indépendant de mortalité. 60 % des complications surviennent en période postopératoire. 11 recommandations en 4 champs : risque préopératoire, stratégie anesthésique, prise en charge postopératoire, obstétrique.

AE

AE = Avis d'experts (Accord fort). Méthode GRADE® Grid, 2 tours de cotation : accord fort obtenu pour les 11 recommandations (100 %) — aucune n'est graduée GRADE 1+/1-/2+/2-.

Champ 1 — Risque préopératoire : score composite

Réf.	Recommandation	Niveau
R1.1	Utiliser un score composite associant (1) le risque lié au type de cardiopathie (classification AHA 2018), (2) le statut physiologique A-D (Tableau 3 ci-dessous) et (3) le risque chirurgical (Tableau 5 ci-dessous), pour évaluer le risque périopératoire en chirurgie non cardiaque. Une procédure sous ALR périphérique est considérée à score composite faible quel que soit le statut de la cardiopathie.	AE
R1.2	Chez un patient à score composite intermédiaire ou élevé, prise en charge en centre expert en cardiopathies congénitales, pour diminuer la survenue de complications périopératoires.	AE

Le tableau de croisement complet (Tableau 6, risque composite final par lésion cardiaque spécifique) n'est pas reproduit ici — classification cardiologique exhaustive lésion par lésion sur plusieurs pages du texte source ; se référer au texte intégral pour calculer le score composite exact d'un patient donné.

Tableau 3 — Statut physiologique (classification AHA 2018)

Thème	Détail
A	NYHA I. Absence de séquelle hémodynamique ou anatomique. Rythme sinusal, absence d'arythmie. Capacité physique normale. Fonctions rénale, hépatique et pulmonaire normales.
B	Séquelles hémodynamiques modérées (dilatation aortique/ventriculaire modérée, dysfonction ventriculaire modérée). Valvulopathie modérée. Shunt trivial. Arythmie ne nécessitant pas de traitement. Limitation cardiaque objective à l'effort.
C	NYHA III. Valvulopathie ou dysfonction ventriculaire modérée à importante. Dilatation aortique modérée. Sténose veineuse ou artérielle. Hypoxémie, cyanose. Shunt significatif. Arythmie contrôlée par traitement. HTAP non sévère. Dysfonction d'organe répondant au traitement.
D	NYHA IV. Dysfonction ventriculaire sévère. Dilatation aortique sévère. Arythmie réfractaire au traitement. Hypoxémie sévère (souvent avec cyanose). HTAP sévère, syndrome d'Eisenmenger. Dysfonction d'organe réfractaire au traitement.

Tableau 5 — Risque chirurgical (approximation du risque de décès à 30 jours et d'infarctus, sans tenir compte des comorbidités — adapté des recommandations ESC/ESA 2014) :

Thème	Détail
Faible (< 1 %)	Chirurgie superficielle, du sein, dentaire, thyroïdienne ; ophtalmologie ; chirurgie reconstructrice ; carotide asymptomatique ; gynécologie mineure ; orthopédie mineure (ex. ménisectomie) ; urologie mineure (RTUP).
Intermédiaire (1-5 %)	Splénectomie, hernie hiatale, cholécystectomie ; carotide symptomatique ; angioplastie périphérique ; anévrisme par voie endovasculaire ; chirurgie tête et cou ; neurochirurgie ; orthopédie majeure (hanche, rachis) ; urologie/gynécologie majeure ; transplantation rénale ; chirurgie thoracique non majeure ; obstétrique.
Élevé (> 5 %)	Chirurgie aortique et vasculaire majeure (revascularisation AOMI, amputation) ; chirurgie duodéno-pancréatique ; hépatectomie, voies biliaires ; œsophagectomie ; perforation digestive ; phéochromocytome ; cystectomie ; pneumonectomie ; transplantation (foie ou poumon).

Champ 2 — Stratégie anesthésique

Réf.	Recommandation	Niveau
R2.1.1	Recourir à l'anesthésie locorégionale plutôt qu'à l'anesthésie générale chaque fois que possible, pour réduire la morbi-mortalité périopératoire.	AE
R2.1.2	Pour une ALR neuraxiale, privilégier la technique titrée ou continue par rapport à la technique non titrée.	AE

Anesthésie et cardiopathie congénitale de l'adulte

Risque préopératoire, stratégie anesthésique, postopératoire, obstétrique, annexes & sources



Réf.	Recommandation	Niveau
R2.2	Adapter la stratégie anesthésique au risque : monitoring standard si risque composite faible ; monitoring hémodynamique continu et invasif de la pression artérielle + mesures régulières de PaO ₂ /PaCO ₂ si risque composite intermédiaire ou élevé ; ajout d'un monitoring de la pression veineuse centrale continue en cas de circulation de Fontan (cf. fiche pratique #5).	AE

Chap 3 — Prise en charge postopératoire

Réf.	Recommandation	Niveau
R3.1	Prise en charge systématique en unité de soins critiques en postopératoire pour les patients à score composite intermédiaire ou élevé — 60 % des complications surviennent en période postopératoire ; surveillance rapprochée en particulier si FEVG préopératoire < 30 % ou cyanose préopératoire (patients Fontan).	AE
R3.2	Prendre un avis spécialisé de cardiologie congénitale adulte en postopératoire : pour les patients à risque composite intermédiaire ou élevé ; en cas de survenue d'une complication quelle que soit sa sévérité ; en cas de chirurgie en urgence sans avis cardiologique préalable.	AE

Chap 4 — Prise en charge en obstétrique

Réf.	Recommandation	Niveau
R4.1	Évaluation de la cardiopathie en centre expert dès le début de la grossesse (statut physiologique, complications), pour toute patiente enceinte porteuse d'une CC.	AE
R4.2	Prise en charge péripartum en centre expert (équipe pluridisciplinaire cardiologue/obstétricien/anesthésiste) pour les patientes à score composite intermédiaire ou élevé — un plan de prise en charge pluridisciplinaire personnalisé est recommandé, en particulier en cas d'HTAP.	AE
R4.3	Privilégier l'anesthésie locorégionale titrée par rapport à l'ALR non titrée ou à l'anesthésie générale, pour réduire la morbi-mortalité péripartum.	AE
R4.4	Surveillance systématique en unité de soins critiques en postpartum pour les patientes à score composite intermédiaire ou élevé — le postpartum immédiat est une période à haut risque de décompensation (défaillance cardiaque, arythmie), notamment entre J0 et J4 en cas d'HTAP.	AE

Annexe — Fiche pratique #1 : gestion périopératoire des traitements

Thème	Détail
Diurétiques	Poursuite la veille ; arrêt le matin de l'intervention ; contrôle de la kaliémie souhaitable, optimisation de la volémie périopératoire.
IEC	Poursuite la veille ; arrêt le matin (≥ 12 h si traitement de l'HTA) ; poursuite si insuffisance cardiaque et/ou FE ventricule systémique < 40 %.
Bêtabloquants	Poursuite la veille et le matin ; en l'absence d'urgence, discuter l'arrêt avec le cardiologue congénitaliste référent.
Inhibiteurs SRAA	Poursuite la veille ; arrêt le matin ; poursuite si insuffisance cardiaque et/ou FE ventricule systémique < 40 %.
Anti-arythmiques	Classe I (flécaïne...) : arrêt la veille et le matin. Classe II/III (cordarone) : poursuite. Digoxine : aucune recommandation ; discuter l'arrêt avec le cardiologue référent en l'absence d'urgence.
Antihypertenseurs pulmonaires (sildénafil, bosentan, prostacycline)	Poursuite la veille et le matin.
AOD (rivaroxaban, apixaban, edoxaban, dabigatran)	Voir les recommandations GIHP ; en l'absence d'urgence, discuter l'arrêt avec le cardiologue référent.

Anesthésie et cardiopathie congénitale de l'adulte

Risque préopératoire, stratégie anesthésique, postopératoire, obstétrique, annexes & sources



Thème	Détail
AVK	Interrompre 5 jours avant une chirurgie à risque hémorragique élevé, relais HBPM/HNF selon la catégorie de risque ; en l'absence d'urgence, discuter du relais/de l'arrêt avec le cardiologue référent (notamment ventricules uniques en prévention primaire).
Antiagrégants plaquettaires	Aspirine : dernière prise J-3 (avis d'expert, arrêt sauf shunt systémico-pulmonaire type Blalock-Taussig ou stent du canal artériel). Clopidogrel/ticagrelor : dernière prise J-5. Prasugrel : dernière prise J-7. Discuter un relais HBPM/HNF postopératoire avec le cardiologue référent.

Autres fiches pratiques du texte source (annexes visuelles, non transcrites intégralement ici — infographies denses, se référer au fichier annexes) :

- Fiche pratique #2 — Pièges du monitoring chez l'adulte porteur de CC (PVC, pression artérielle, débit cardiaque, EtCO₂, SpO₂, abord vasculaire)
- Fiche pratique #3 — Principes d'anesthésie des patients porteurs de CC hors chirurgie cardiaque
- Fiche pratique #4 — Protocole pour l'anesthésie en urgence d'un patient porteur d'une HTAP iso- ou supra-systémique
- Fiche pratique #5 — Protocole pour l'anesthésie en urgence d'un patient porteur d'une dérivation cavo-pulmonaire (Fontan)
- Fiche pratique #6 — Conduite à tenir par situation physiopathologique en anesthésie obstétricale

Sources et avertissement

SFAR, en association avec la Société Française de Cardiologie (SFC), la Société Française de Pédiatrie (SFP), le Club Anesthésie-Réanimation en Obstétrique (CARO) et la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (SFCTCV), « Anesthésie pour chirurgie non cardiaque des patients adultes porteurs de cardiopathie congénitale », RPP, 2023. Comité de 16 experts. Bibliographie extensive dans le texte intégral (non reproduite ici).

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend intégralement le texte des 11 recommandations et les Tableaux 3 et 5 (statut physiologique, risque chirurgical), mais ne reproduit pas le Tableau 6 (croisement complet risque composite par lésion cardiaque spécifique — classification cardiologique exhaustive) ni les fiches pratiques annexes #2 à #6 (infographies visuelles), disclosed comme hors périmètre de cette passe. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFAR. **Note sur le téléchargement :** les deux fichiers proposés par sfar.org pour ce document ont des noms trompeurs — le fichier sans « -annexes » dans son nom contient en réalité les fiches pratiques visuelles, celui avec « -annexes » contient le texte principal complet synthétisé ici.